

Intoxicaciones y abstinencias

1. Introducción y relevancia clínica

Las **intoxicaciones agudas** y los **síndromes de abstinencia** por sustancias psicoactivas son una causa frecuente de atención en **urgencias psiquiátricas y médicas**, y constituyen un **problema de salud pública creciente** en Chile y Latinoamérica.

Estas situaciones pueden comprometer la conciencia, la conducta y la fisiología, generando **riesgo vital inmediato** (por depresión respiratoria, convulsiones o arritmias), además de complicaciones psiquiátricas graves (delirium, psicosis, suicidio).

Relevancia clínica

- Hasta el **30% de las urgencias psiquiátricas** se relacionan con consumo de sustancias.
- Las intoxicaciones más frecuentes son por **alcohol, benzodiacepinas, cocaína, cannabis y opiáceos**.
- Las **abstinencias graves** pueden producir **crisis convulsivas, delirium tremens y muerte** si no se tratan adecuadamente.

□ En **EUNACOM**, son preguntas clásicas los cuadros de **intoxicación alcohólica, síndrome de abstinencia o delirium tremens**, y su manejo farmacológico de urgencia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismos generales

Las sustancias psicoactivas alteran la neurotransmisión en los principales sistemas cerebrales:

Sistema

Sustancias
estimulantes

Sustancias depresoras

Dopaminérgico	Cocaína, anfetaminas (↑ liberación)	Alcohol crónico (↓ sensibilidad dopaminérgica)
GABAérgico	—	Alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos (↑ inhibición)
Glutamatérgico (NMDA)	—	Alcohol (bloquea); su suspensión → hiperexcitabilidad.
Serotoninérgico	MDMA, LSD (↑ serotonina)	—

Durante la **intoxicación aguda**, predomina la acción directa del fármaco sobre los receptores.

Durante la **abstinencia**, ocurre el efecto contrario (rebote), debido a la adaptación neuroquímica crónica.

2.2. Principales grupos de sustancias

1. **Depresoras del SNC:** alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos, opiáceos.
2. **Estimulantes:** cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína.
3. **Alucinógenas:** LSD, psilocibina, cannabis (THC en altas dosis).
4. **Disociativas:** ketamina, fenciclidina (PCP).
5. **Inhalantes:** tolueno, éter, pegamentos.

Cada grupo puede producir tanto intoxicación como síndrome de abstinencia con manifestaciones específicas.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Intoxicación aguda

Se caracteriza por alteración reciente del comportamiento o del nivel de conciencia tras consumo de una sustancia.

Manifestaciones generales

- Cambios en el ánimo, conducta o cognición.
 - Alteración del juicio, desinhibición o agitación.
 - Alteraciones autonómicas (taquicardia, presión, sudoración).
 - Somnolencia o coma en casos graves.
-

3.2. Síndrome de abstinencia

Ocurre tras la reducción o suspensión brusca de una sustancia usada en forma prolongada.

Mecanismo general

Por adaptación del sistema nervioso central a la exposición crónica, la suspensión genera un **rebote de hiperexcitabilidad** (lo opuesto al efecto agudo).

Manifestaciones comunes

- Ansiedad, insomnio, irritabilidad.
 - Temblor, taquicardia, hipertensión.
 - Náuseas, sudoración, convulsiones (en abstinencia severa).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial (ABCDE psiquiátrico)

1. **A:** vía aérea permeable.
2. **B:** respiración y saturación.
3. **C:** signos vitales, pulso, presión.
4. **D:** nivel de conciencia (Glasgow), pupilas.

5. **E:** búsqueda de drogas, objetos o frascos.

□ Toda intoxicación con compromiso de conciencia debe tratarse inicialmente como **emergencia médica**, no psiquiátrica.

4.2. Exámenes complementarios básicos

- Glicemia capilar (descartar hipoglicemia).
 - Tóxicos en orina (benzodiacepinas, cocaína, cannabis, opiáceos).
 - Hemograma, electrolitos, función hepática y renal.
 - ECG (prolongación QT, arritmias).
 - Niveles plasmáticos específicos si disponibles (alcohol, litio, valproato).
-

4.3. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Claves diferenciales
Delirium metabólico	Fluctuante, con alteración de conciencia y causa médica subyacente.
Episodio maníaco	Insomnio sin fatiga, grandiosidad, gasto.
Esquizofrenia	Síntomas psicóticos sin consumo reciente.
Trastorno de ansiedad o pánico	Hiperventilación, miedo a morir sin consumo.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo de intoxicaciones y abstinencias debe ser **multifásico**:

1. **Estabilización vital.**
 2. **Tratamiento específico según sustancia.**
 3. **Prevención de complicaciones.**
 4. **Derivación y rehabilitación.**
-

5.1. Intoxicación por alcohol

Clínica:

- Desinhibición, incoordinación, disartria, somnolencia.
- En niveles >300 mg/dl: coma y depresión respiratoria.

Manejo:

1. ABC + monitorización.
 2. Glicemia y tiamina 100 mg EV antes de suero glucosado (previene encefalopatía de Wernicke).
 3. Hidratación y control electrolítico.
 4. Si agitación: **haloperidol 2,5–5 mg IM** (evitar benzodiacepinas).
 5. Si coma alcohólico: manejo en UCI.
-

5.2. Síndrome de abstinencia alcohólica

Inicio:

6–24 h tras suspensión.

Pico:

48–72 h.

Duración:

hasta 7 días.

Tipo	Características	Tratamiento
Leve	Ansiedad, temblor, sudoración.	Diazepam VO 10 mg cada 8 h (reducir progresivamente).
Moderado-grave	Taquicardia, hipertensión, agitación, alucinaciones.	Diazepam EV 10–20 mg cada 2–4 h; tiamina 100 mg EV.
Delirium tremens	Confusión, agitación, fiebre, alucinaciones.	UCI, diazepam EV + haloperidol + hidratación + soporte intensivo.

☐ El **delirium tremens** es una emergencia vital con mortalidad hasta del 20% si no se trata.

5.3. Intoxicación por benzodiacepinas

Clínica:

Somnolencia, ataxia, hipotonía, depresión respiratoria (con alcohol u opiáceos).

Tratamiento:

- ABC y soporte ventilatorio.
- **Flumazenil 0,2 mg EV** (antagonista específico) *solo si no hay uso crónico* ni riesgo de convulsiones.
- Evitar si sospecha policonsumo o epilepsia.

☐ En consumo crónico, el flumazenil puede inducir convulsiones graves.

5.4. Abstinencia de benzodiacepinas

- Aparece 2–5 días tras suspensión.
- Síntomas: ansiedad intensa, insomnio, temblores, convulsiones.

Tratamiento:

- Reintroducir benzodiacepina de vida media larga (diazepam 5–10 mg VO cada 8 h) y reducir lentamente en 2–3 semanas.
 - Control ambulatorio estricto o internación si hay riesgo vital.
-

5.5. Intoxicación por cocaína o anfetaminas**Clínica:**

Euforia, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, midriasis.

En sobredosis: arritmias, convulsiones, IAM, ACV.

Tratamiento:

1. ABC, control de temperatura, hidratación.
 2. **Benzodiacepinas (diazepam 10 mg EV)** → primera línea para agitación, convulsiones o hipertensión.
 3. **Evitar betabloqueadores puros** (riesgo de vasoespasmo coronario).
 4. Si psicosis: haloperidol 2–5 mg IM.
-

5.6. Abstinencia de cocaína

- Síndrome de depleción dopaminérgica: disforia, fatiga, hipersomnia, anhedonia.
 - Manejo: observación, apoyo psicológico, control de riesgo suicida.
 - No requiere medicación específica.
-

5.7. Intoxicación por opiáceos (heroína, morfina, metadona)**Clínica:**

Miosis puntiforme, bradipnea, bradicardia, coma.

Signos clásicos: **“coma, miosis y depresión respiratoria.”**

Tratamiento:

1. ABC y ventilación asistida.
 2. **Naloxona 0,4 mg EV**, repetir cada 2–3 min hasta revertir depresión respiratoria (máx 10 mg).
 3. Si consumo de metadona: observar ≥ 12 h (vida media prolongada).
 4. Prevenir recaída posterior → derivar a programa de metadona o buprenorfina.
-

5.8. Abstinencia de opiáceos

Inicio 6–12 h tras suspensión; pico a 48–72 h.

Síntomas: midriasis, rinorrea, piloerección, diarrea, dolor osteomuscular, ansiedad.

Tratamiento:

- **Clonidina 0,1 mg VO cada 8 h** (control autonómico).
 - **Metadona o buprenorfina** (si disponible, bajo programa supervisado).
 - Hidratación y analgésicos.
-

5.9. Intoxicación por cannabis

- Ansiedad, taquicardia, paranoia, alucinaciones, despersonalización.
 - Tratamiento: observación, ambiente tranquilo, benzodiacepina (lorazepam 1–2 mg VO).
 - Remite en 6–12 h.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Depresión respiratoria** (opiáceos, benzodiazepinas, alcohol).
- **Convulsiones** (cocaína, abstinencia alcohólica).
- **Delirium tremens** (abstinencia etílica grave).
- **Síndrome neuroléptico maligno o serotoninérgico** en policonsumo.
- **Rabdomiólisis, ACV o infarto** en estimulantes.

Pronóstico

- La mayoría se recupera con manejo agudo adecuado.
- Requiere **intervención psicosocial posterior**: sin ella, la recaída es la norma.
- Mejor pronóstico con programas de **rehabilitación integral y seguimiento psiquiátrico**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. En **delirium tremens**, el tratamiento es **benzodiazepinas + tiamina**, nunca antipsicóticos solos.
2. En **intoxicación por opiáceos**, naloxona es el antídoto específico.
3. Evite **flumazenil** en usuarios crónicos de benzodiazepinas.
4. En **cocaína**, el tratamiento de elección es **diazepam**, no haloperidol como primera línea.
5. Toda intoxicación con compromiso de conciencia debe manejarse como **emergencia médica**.
6. Siempre corregir **glicemia y electrolitos** antes de asumir origen psiquiátrico.
7. En abstinencia alcohólica, **siempre administrar tiamina antes de glucosa**.



Errores comunes

- Usar haloperidol en abstinencia alcohólica grave.
- Administrar flumazenil a consumidor crónico.
- No monitorizar vía aérea tras naloxona.
- Tratar agitación por cocaína con antipsicóticos sin benzodiacepinas.
- No realizar evaluación médica completa.
- Omitir derivación a programa de rehabilitación tras el alta.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **intoxicaciones y abstinencias** son emergencias psiquiátricas frecuentes y potencialmente letales.
2. El manejo inicial siempre sigue el esquema **ABCDE + glicemia**.
3. En **alcoholismo**, usar **diazepam + tiamina**; evitar antipsicóticos en monoterapia.
4. En **opiáceos**, administrar **naloxona** y mantener vigilancia respiratoria.
5. En **benzodiacepinas**, evitar flumazenil si uso crónico.
6. En **estimulantes (cocaína, anfetaminas)**, la primera línea es **diazepam EV**.
7. Todo paciente estabilizado debe derivarse a **rehabilitación integral** y seguimiento psiquiátrico.